

GP协作专业答复

生成时间：2026-05-29 19:25:24

GP协作专业答复报告

长者姓名：陈萍忠

评估日期：返院第7日

核心问题：BPSD症状加重、认知干预依从性差、家属照护焦虑

一、GP确认意见

基于最新临床观察与智能计算图谱分析，确认以下关键点：

- 疾病阶段**：阿尔茨海默病**中重度期（Stage 4）**，属功能衰退主导亚型（Subtype 1），符合本地序贯分期模型诊断（事件触发数3/4）。
- 风险量化**：
 - BPSD症状30日内升级概率 **42.65%**（贝叶斯后验，超30%干预阈值）
 - 跌倒及二次头部外伤30日风险 **51.75%**（高风险矩阵确认）
 - 药物相互作用致骨髓抑制风险 **高**（WBC/PLT持续偏低）
- 干预紧迫性**：需在**7日内**完成精神科会诊与用药审查，同步启动家属支持计划。

二、精神科会诊决策

会诊必要性（贝叶斯决策阈值触发）

- **必须会诊**：当前BPSD表现为**拒绝配合康复**（NPI评分9分），叠加认知功能严重下降（MoCA反向Z-score=1.21），符合抗精神病药使用评估指征。
- **药物审查重点**：
 - 评估奥氮平（1mg qn）与劳拉西泮（2mg qn）的必要性及剂量合理性
 - 排查多奈哌齐+美金刚+他汀联用对骨髓抑制的贡献度
 - 建议加测肝肾功能、电解质及凝血功能

非药物干预调整建议

| 原方案痛点 | 优化策略 | 执行主体 |

|-----|-----|-----|

| 上午康乐活动单一 | **分时段兴趣嵌入**：
-

上午：怀旧音乐疗法（结合老上海舞曲）
-
下午：坐式舞蹈训练（利用其跳舞喜好，降低体力要求） | 康复治疗师 |
| 夜间睡眠<7小时 | **睡眠卫生强化**：
-
18:00后禁咖啡因
- 20:00温水泡脚+轻柔按摩
-
移除夜间不必要的药物唤醒 | 护理团队 |

三、照护目标更新

原目标修正（基于一周执行反馈）
原14天目标	更新后目标（D7-D21）	量化指标

增加下午认知刺激	**提升非药物干预接受度**	
下午活动参与率≥50%（当前<20%）		
稳定睡眠≥7小时	**改善睡眠连续性**	
夜间觉醒次数≤1次/晚，总时长≥6.5小时		
家属焦虑缓解	**建立结构化支持机制**	
家属每周参与1次照护技能培训，焦虑量表评分下降≥20% |

新增安全目标

- **零跌倒防护**：夜间如厕全程陪护（22:00-6:00），浴室防滑垫覆盖率100%
- **药物安全**：完成用药精简，停用≥1种非必要药物（目标：总用药≤8种）

四、多方协同分工

角色	职责	时间节点
GP/精神科	1. 会诊评估BPSD药物方案 2. 审查并优化用药清单 3. 签署行为干预医嘱	D7前完成
护理团队	1. 执行24小时防跌倒流程 2. 监测皮肤完整性及消化道症状 3. 记录睡眠日志（含觉醒原因）	持续执行
康复治疗师	1. 设计坐式舞蹈方案（每日15分钟） 2. 评估活动耐受性	D3启动
社工/心理师	1. 家属照护技能培训（含BPSD应对技巧） 2. 提供喘息服务资源链接	每周1次
药剂师	1. 用药相互作用分析 2. 制定服药简化方案	

D5前提交报告 |

****GP签字**** : _____

****日期**** : 2026年4月24日